



DISCIPLINAS COMPLEMENTARES
DIREITO PREVIDENCIÁRIO
ANA JÚLIA KACHAN
AULA 6

ROTEIRO DE AULA

Sumário

TEMA: Benefícios Por Incapacidade

1. Aposentadoria por invalidez/aposentadoria por incapacidade permanente (nomenclatura pós reforma da previdência)
2. Auxílio-doença (auxílio por incapacidade temporária):
3. Auxílio acidente

TEMA: Benefícios Por Incapacidade

Se o sistema da previdência social identificar que o segurado tem uma incapacidade para o trabalho que o enquadra nos requisitos para uma aposentadoria por incapacidade permanente, o sistema pode conceder o benefício de ofício, independentemente de ato volitivo do segurado. É muito alta a judicialização dessa temática dada a complexidade de tema e grande demanda.

**APOSENTADORIA POR INVALIDEZ/APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE (NOMENCLATURA
PÓS REFORMA DA PREVIDÊNCIA)**



A Constituição Federal no art. 201, I, entre os riscos sociais cobertos tirou a expressão “doença” para inserir a expressão “incapacidade”. A doença pode não gerar nenhuma incapacidade, então a mudança de nomenclatura é adequada.

É por essa razão que o decreto n. 3048/99 alterado pelo decreto 10.410/20 traz a previsão da nova nomenclatura do benefício como sendo aposentadoria por incapacidade permanente. Na lei previdenciária (Lei n. 8.213/91), ainda encontraremos apenas a expressão “aposentadoria por invalidez” e ainda em muitas doutrinas.

Fundamento legal: Artigos 42 a 47 da Lei 8213/91

É devida a todos os tipos de segurados, em razão de incapacidade total e definitiva para o trabalho e dura enquanto permanecer esta condição.

Na espécie acidentária, contudo, temos restrições de categorias de segurado por força da questão contributiva, de que apenas as figuras que fazem custeio específico do seguro de acidente de trabalho é que fazem jus às prestações por acidente do trabalho (empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e segurado especial).

A incapacidade total e permanente está associada à impossibilidade de reabilitação e de exercer qualquer atividade que garanta a subsistência. Esse “total” a jurisprudência acaba flexibilizando porque o entendimento é de que pode ser (a depender da avaliação de outros elementos) que se tenha um segurado com uma incapacidade parcial, porém a condição pessoal dele socioeconômica, de escolaridade impede o exercício de qualquer atividade que garanta a sua subsistência.

- **Exemplo:** um segurado de 55 anos de idade, analfabeto, que tem um problema seríssimo na coluna e que não tem mais condição de exercer qualquer atividade relacionada ao uso da coluna, ele não pode atividades com posições viciosas, não pode atividade de esforço físico para a coluna, nada disso.

Teoricamente, ele pode exercer outras atividades para as quais não se exige esforço físico da coluna, mas a condição pessoal e social dele não vai permitir que ele exerça essas atividades e talvez nem o processo de



reabilitação profissional seja capaz de recolocá-lo em atividade compatível. Então, aqui temos a flexibilização do conceito de incapacidade total para o trabalho, porque precisamos analisar não só o aspecto médico, mas também outros aspectos relacionados à própria condição individual do segurado.

Também precisamos compreender que o “permanente” não é o permanente de “definitivo”, no sentido de que o benefício não possa ser revisto pelo sistema. Quando falamos que a incapacidade é permanente para originar uma aposentadoria por incapacidade permanente, estamos trabalhando com o prognóstico médico.

Naquele momento da avaliação pericial, se identifica que não é possível reverter aquele quadro, que, em uma primeira análise, ele não tem possibilidade de reversão ou cura. O prognóstico desfavorável para a reversão da incapacidade é que vai originar a aposentadoria por incapacidade permanente porque o benefício pode ser revisto pelo sistema a qualquer momento. O segurado pode ser convocado para a reavaliação das condições que ensejaram a concessão do benefício.

Não é vitalícia

A reavaliação, os “pente-fino” do INSS são feitos pela perícia médica federal. A aposentadoria por incapacidade permanente provoca o efeito de suspensão do contrato de trabalho porque, lá na frente, se o INSS chama e acha que o segurado está bom para voltar a trabalhar, ele tem o contrato de trabalho para reassumir o cargo. As empresas não podem rescindir o contrato de trabalho do empregado que está aposentado por invalidez e chega na Justiça do Trabalho a discussão relacionada a esta temática.

O pode voltar por ato voluntário ao trabalho, pedindo ao INSS que cancele a aposentadoria por incapacidade permanente. Temos que o retorno voluntário ao trabalho também é forma de cessação da aposentadoria por incapacidade permanente.

Não necessariamente deve ser precedida de um auxílio-doença.



Vínhamos das aposentadorias voluntárias, programadas, que dependem que o segurado busque a previdência. Aqui, essa aposentadoria por incapacidade permanente pode ser concedida de ofício pelo INSS caso este tome ciência de tal fato, o que é difícil de ocorrer.

Na vida real, o sistema concede o auxílio por incapacidade temporária porque é o adequado para o período de tratamento médico, para que se avalie o prognóstico e mais adiante se converte em aposentadoria por incapacidade permanente se realmente aquela condição do segurado não indicar possibilidade de reversão. Contudo, pode ser que o segurado vá direto para a aposentadoria por invalidez.

O risco protegido é a incapacidade laboral. É benefício substitutivo dos salários, já que o aposentado por invalidez tem vedação legal de voltar às atividades, sob pena de suspensão do benefício previdenciário.

Quando falamos que se trata de um benefício que substitui salário, a consequência disso é que não pode ser inferior a 1 salário-mínimo, então existe essa garantia.

Há necessidade de comprovação da invalidez, por meio de exame médico a ser realizado por perito oficial, podendo o segurado ser acompanhado, na perícia, por médico de sua confiança, às suas expensas.

Não existe impedimento que o segurado pagando o médico particular dele, de sua confiança, para o acompanhar na perícia.

A incapacidade geradora da aposentadoria por invalidez há de impedir o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência → condições pessoais.

Trata-se de incapacidade laborativa, e não de incapacidade absoluta, total e completa.

Algumas vezes temos associada à incapacidade laborativa – aquele impedimento de exercer uma atividade que garanta a subsistência – uma incapacidade para os atos da vida civil, que faria com que o segurado precisasse ser



interditado, mas as duas coisas não caminham paralelamente. Temos muitos casos de incapacidade apenas e tão somente laborativa, como no exemplo do segurado com problema sério de coluna.

Assim como é distinto o conceito de deficiência porque além da análise médica dessa deficiência física, mental, intelectual ou sensorial, precisamos da análise do quanto as barreiras que o sujeito enfrenta lhe impedem de concorrer em condições de igualdade dentro da sociedade.

Doença preexistente e relação jurídica previdenciária

A preexistência vem justamente na ideia de que não podemos entrar no sistema já sabendo que vamos usar o sistema. Não podemos fazer o seguro do carro depois que batemos o carro, temos que fazer o seguro para que, se eu bater o carro, possa usar dessa apólice que firmou. Aqui é a mesma coisa, não podemos começar a pagar o INSS já sabendo que não tem condições de trabalho porque viola a teoria do risco. Doença é diferente de incapacidade, então pode entrar no sistema estando doente, o que não pode é entrar no sistema incapacitado.

A cobertura previdenciária é vedada ao segurado que ingressa no sistema já incapacitado para o trabalho. Há cobertura, entretanto, se a incapacidade decorrer de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Segundo a norma inscrita no § 2º do artigo 42 da Lei 8.213/91, “A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

Às vezes a pessoa começa a pagar o INSS e tem uma doença cardíaca, só que ela não tem sintoma nenhum, está plenamente capaz para o trabalho. Não tem nenhum impedimento, ela vai seguir contribuindo à previdência social. Se adiante ela eventualmente passar a desenvolver uma incapacidade que seja da própria progressão ou agravamento da doença, ela vai fazer jus ao benefício por incapacidade correspondente porque o sistema cobre a incapacidade e não a doença.



A carência é de **12 contribuições mensais** para a aposentadoria por invalidez comum; e **não há carência** para acidente do trabalho ou de qualquer natureza, doenças profissionais ou doenças do trabalho e doenças catalogadas pelo Ministério Ex: tuberculose, hanseníase, neoplasia maligna; AIDS → art. 151 da Lei n. 8.213/91. Segundo a TNU, trata-se de rol exemplificativo.

Diferentemente das aposentadorias por tempo, idade e especial, é exigida a qualidade de segurado.

Se o sujeito perdeu a qualidade de segurado, está incapacitado para o trabalho, então ele tenta cumprir a regra e pagar metade da carência para recuperar tudo e pedir a aposentadoria por incapacidade permanente, isso não poderá ser feito porque se estará violando a teoria do risco. A nova filiação ao sistema já se deu no momento em que se estava incapacitado para o trabalho.

Bloco 2

Em caso de grande invalidez (art. 45 da Lei 8.213/91) acrescenta 25% sobre o valor do salário de benefício, ainda que ultrapasse o limite superior do salário de benefício (teto).

É aquela situação em que o segurado necessita do auxílio permanente de um terceiro para atos básicos da vida diária, como se vestir, se alimentar, higiene pessoal, etc. Nesses casos, ele tem direito a um adicional de 25% sobre o salário de benefício e essa é uma regra que escapa do limite teto. Imagine o caso do segurado com esquizofrenia que, além de não ter condições de trabalhar, também precisou ser interditado porque não tem condições de fazer nada sozinho

A grande invalidez é a incapacidade total e permanente de tal proporção que acarreta a necessidade permanente do auxílio de terceiros para o desenvolvimento das atividades cotidianas, em virtude da amplitude da perda da autonomia física, motora ou mental, que impede a pessoa de realizar os atos diários mais simples, tal como as necessidades fisiológicas.



A grande invalidez é personalíssima, de modo que o acréscimo de 25% não se transmite à pensão por morte. O propósito dos 25% está muito relacionado ao custeio desse terceiro que vai realizar as atividades básicas da vida diária do segurado e a necessidade acaba com o falecimento do segurado, então esses 25% não se transferem para a pensão por morte.

Obs. para o STF, somente na aposentadoria por invalidez há o direito desse acréscimo

ANTES DA EC 103/19	DEPOIS DA EC 103/19
- Independentemente de ser acidente do trabalho ou não, a aposentadoria por invalidez era 100% do salário de benefício (média dos 80% maiores). - Se o segurado tinha a necessidade do terceiro para atos básicos da vida diária, acrescentaríamos os 25% - Quando o segurado morre, a pensão por morte vai ser calculada em 100% porque não se usa os 25%	- A aposentadoria por incapacidade permanente é 60% + 2% por cada ano que passa 15 para a mulher e 20 para o homem. - Se for acidente do trabalho, temos 100%. Os coeficientes se aplicam ao salário de benefício (média de tudo, de 100%, sem eliminar os menores)

Relação das situações de grande invalidez, estão no Anexo I do Decreto 3048/99 (rol exemplificativo) e são as seguintes:

- 1- Cegueira total;**
- 2- Perda de nove dedos das mãos ou superior a esta;**
- 3- Paralisia dos dois membros superiores ou inferiores;**
- 4- Perda dos membros inferiores, acima dos pés, ainda que a prótese seja possível;**



- 5- Perda de uma das mãos e de dois pés, ainda que a prótese seja possível;**
- 6- Perda de um membro superior e outro inferior, quando a prótese for impossível;**
- 7- Alteração das faculdades mentais com grave perturbação da vida orgânica e social;**
- 8- Doença que exija permanência continua no leito;**
- 9- Incapacidade permanente para as atividades da vida diária;**

É preciso que a perícia médica analise naquela situação concreta se há essa necessidade de um terceiro ou não. Essa necessidade do auxílio permanente de um terceiro não obrigatoriamente vai acontecer concomitante ao momento da concessão da aposentadoria por incapacidade permanente.

Imagine que o segurado sofreu um acidente e tem sequelas motoras graves e o sistema identifica desde logo que ele está em uma condição de Insuscetibilidade de reabilitação, de impossibilidade de exercer atividade que garanta sua subsistência e concede para ele uma aposentadoria por incapacidade permanente.

Inicialmente, ele conseguia cuidar de si sozinho, mas, com o tempo, seu problema foi agravando a ponto de, depois de 5 anos que ele pediu essa aposentadoria por incapacidade permanente, ele identificou que ele faria jus a este acréscimo de 25%. Isso é possível porque essa necessidade não necessariamente acompanha o termo inicial da aposentadoria por incapacidade permanente.

Há a possibilidade de extensão deste adicional para outras aposentadorias (Tema 1095 do STF)? O STF recentemente entendeu pela impossibilidade. O acréscimo de 25% está inserido em um Capítulo próprio da Lei n. 8.213/91, exatamente no capítulo da aposentadoria por invalidez, mas com o tempo, passou a se discutir a possibilidade da extensão desse adicional nas outras espécies de aposentadoria porque se percebia que muitos segurados aposentados por outras espécies de aposentadoria preenchiam o requisito da necessidade do terceiro.

Um homem que se aposentou por idade com 65 anos e que, depois de sua aposentadoria, quando ele estava com 75 ou 80 anos de idade, ele descobriu que tinha Alzheimer e, em razão disso, ele começou a sofrer as consequências da doença até o ponto em que ele estava em uma situação de só ficar na cama, não se alimentar sozinho, não se locomover sozinho e passou a precisar permanentemente de um terceiro para os atos básicos da



vida diária. O sistema nega o adicional porque a aposentadoria de base dele é uma aposentadoria por idade e o sistema só paga o adicional na aposentadoria por incapacidade permanente.

Essa discussão tramitou no Judiciário, chegou ao STJ que tinha um entendimento favorável à extensão às demais espécies de aposentadoria, bateu no STF que julgou recentemente o Tema 1095 por maioria dizendo que não é possível estender o adicional de 25% às outras espécies de aposentadoria pela falta de previsão legal específica.

O benefício (aposentadoria por incapacidade permanente) é devido:-

I- se o segurado estava recebendo auxílio-doença, a partir do dia imediatamente seguinte à alta deste;

II- se o segurado não estava recebendo auxílio-doença:

a) empregado: a contar do 16º dia de afastamento ou a partir da entrada do requerimento se entre esse e o afastamento decorrerem mais de 30 dias;

b) empregado doméstico, avulso, contribuinte individual, especial e facultativo: a contar do início da incapacidade ou da data do requerimento se entre essas duas transcorrerem mais de 30 dias.

Quando a EC 103/19 veio, ela alterou o critério de cálculo das aposentadorias, trazendo essa regra dos 60% + 2% por cada ano que passe 15 para a mulher e 20 para o homem, mas a Reforma não mudou o cálculo do auxílio-doença, que é calculado em 91% do salário de benefício. A aposentadoria por incapacidade permanente que está na regra nova de cálculo ou 100% se for acidente de trabalho.

O empregador doméstico não tem a obrigatoriedade de pagar os primeiros 15 dias de salário, porém, pelo decreto, o empregado doméstico só vai sair em benefício se ele ficar com uma incapacidade maior do que 15 dias. Se ele ficar afastado do trabalho por 14 dias (COVID), existe um limbo porque a lei não manda nem o empregador doméstico e nem o INSS pagar por esse período. A regra dos 15 dias é para o empregado.

O benefício cessa:-

1- com a morte do segurado, gerando pensão por morte se o caso (art. 15, I da Lei n. 8.213/91 – gerará pensão por morte se ele tiver dependentes que preencham os requisitos do art. 16 da Lei n. 8.213/91);



2- pelo retorno voluntário ao trabalho,

3- com a recuperação da capacidade (perícia médica federal), observados os seguintes critérios:

Convocação do INSS para reavaliação das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente – “pente fino do INSS”.

a) se a recuperação for total e ocorrer dentro de cinco anos, contados da data do início da aposentadoria ou do auxílio-doença: imediatamente para o segurado empregado que tiver direito a retomar a função ou após tantos meses quantos forem os anos de duração do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez para os demais segurados;

Chamamos isso de mensalidade de recuperação. Imagine o Zé que ficou 2 anos recebendo auxílio-doença. Depois ele ficou 2 anos aposentado por invalidez. Zé foi chamado na perícia de reavaliação do INSS e o INSS entendeu que o Zé está bom, que ele tem condições de trabalho e que ele pode voltar a exercer sua atividade.

Ele ficou menos de 5 anos. Se a recuperação for total e ocorrer dentro de 5 anos, temos que ver se ele tem direito de retomar a sua função. Se quando ele saiu em auxílio-doença que depois virou aposentadoria por invalidez, ele estava vinculado a uma empresa e o seu contrato de trabalho foi suspenso, ele tem direito de retomar a função.

Contudo, Zé saiu da última empresa e 8 meses depois, quando ele estava no período de graça, de manutenção da qualidade de segurado, ele descobriu uma doença grave, ficou 2 anos em auxílio-doença e 2 anos aposentado por invalidez. Zé terá direito à mensalidade de recuperação por tantos meses quantos forem os anos de duração do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez. No total, ele tem 4 anos, então ele terá 4 meses de mensalidade de recuperação.

b) se a recuperação for parcial ou total, mas ocorrer após 5 anos, a aposentadoria será mantida, independentemente da volta ao trabalho:

- no seu valor integral durante 6 meses;
- com redução de 50% nos próximos 6 meses;



- com redução de 75% por mais 6 meses, após o qual cessará definitivamente.

Imagine alguém que estava com auxílio-doença por 3 anos e ficou aposentado por invalidez por 5 anos, gozando de benefício há 8 anos. Aqui, a mensalidade de recuperação vai ser devida mesmo que tenha direito de voltar ao trabalho, nada tendo a ver com o tempo de benefício.

Ele tem 18 meses de mensalidade de recuperação porque vai ficar 6 meses recebendo 100% da aposentadoria, 6 meses recebendo 50% da aposentadoria e mais 6 meses recebendo 25% da aposentadoria. É como se fosse um período de adaptação do segurado à vida sem a aposentadoria. Há interesse de agir para demandar judicialmente discutindo a decisão administrativa que ordenou a cessação do benefício, não é necessário esperar a mensalidade de recuperação terminar e esse é o entendimento que vem prevalecendo especialmente na TNU.

Dispõe o artigo 475 da Consolidação das Leis do Trabalho que “O empregado que for aposentado por invalidez terá suspenso o seu contrato de trabalho durante o prazo fixado pelas leis de previdência social para a efetivação do benefício”.

Para o benefício acidentário sempre e para o benefício previdenciário, de forma intercalada. Com relação a essa temática, o STF julgou o Tema 1.125 para dizer que o benefício intercalado vale como tempo de contribuição e como carência. O STF usa a expressão “intercalado entre períodos de atividade”, o que está gerando um debate nas outras instâncias se valeria contribuição facultativa ou se teria que ser contribuição obrigatória.

Resta claro, assim, que a aposentadoria por invalidez não constitui causa de extinção do contrato de trabalho, mas sim de suspensão, o que implica necessária conclusão no sentido de que o empregado deve reassumir seu posto de trabalho no caso de recuperação da capacidade laborativa com consequente cancelamento da aposentadoria (artigo 47 – Lei 8.213/91)

ATENÇÃO: - LEI 13.457/2017 –



Art. 43 § 4º O segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial ou administrativamente, observado o disposto no art. 101 desta Lei.”

Essa lei materializou o entendimento administrativo da necessidade de fixação de termo de cessação no auxílio-doença, como a necessidade de reavaliação do benefício concedido na via judicial ou administrativa. Sempre se discutiu judicialmente não só a validade dessa alta programada, dessa cessação prevista de benefício, mas principalmente a possibilidade de o sistema reavaliar administrativamente um benefício que teria concedido judicialmente pelo paralelismo, no entendimento de que se alguém tivesse sido aposentado pela via judicial, a revisão também deveria ser pela via judicial. Contudo, o sistema pode reavaliar pela via administrativa ou judicial.

§ 5º Os segurados com síndrome da imunodeficiência adquirida, doença de Alzheimer, doença de Parkinson e esclerose lateral amiotrófica são dispensados da avaliação referida no § 4º deste artigo. [\(Redação dada pela Lei nº 15.157, de 2025\)](#)

§ 6º Se a perícia médica constatar que a incapacidade é permanente, irreversível ou irrecuperável, o segurado aposentado por incapacidade permanente é dispensado da reavaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedidos judicial ou administrativamente, salvo quando houver fundamentada suspeita de fraude ou erro. [\(Incluído pela Lei nº 15.157, de 2025\)](#)

ATENÇÃO: - LEI 13.457/2017 –

Art.101:- (AUX ACIDENTE -2022)

§ 1º O aposentado por invalidez e o pensionista inválido que não tenham retornado à atividade estarão isentos do exame de que trata o caput deste artigo:

I - após completarem cinquenta e cinco anos ou mais de idade e quando decorridos quinze anos da data da concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que a precedeu; (HAVIA SIDO REVOGADO PELA MP 871/19, MAS NÃO FOI CONVERTIDO NA LEI 13.846/19) ou



- 55 anos de idade + 15 anos de benefício (auxílio doença e aposentadoria por incapacidade), está dispensado da reavaliação médica do sistema. Não é definitivo esse benefício porque existe a possibilidade do retorno voluntário.

II - após completarem sessenta anos de idade.

§ 2º A isenção de que trata o § 1º não se aplica quando o exame tem as seguintes finalidades:

I - verificar a necessidade de assistência permanente de outra pessoa para a concessão do acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do benefício, conforme dispõe o art. 45;

II - verificar a recuperação da capacidade de trabalho, mediante solicitação do aposentado ou pensionista que se julgar apto;

É esta regrinha que acaba comprometendo, atrapalhando um pouco a tese de que nessas situações a aposentadoria seria definitiva e autorizaria na forma do art. 475 da CLT a rescisão do contrato de trabalho.

III - subsidiar autoridade judiciária na concessão de curatela, conforme dispõe o art. 110.

Bloco 3

SÚMULA 576 STJ - Ausente requerimento administrativo no INSS, o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente será a data da citação válida.

Tema 350 do STF – necessidade de prévio requerimento administrativo, sob pena de inexistência de interesse de agir do segurado.

Tema 982 – STJ – JULGADO – Admite a possibilidade da concessão do acréscimo de 25%, previsto no art. 45 da Lei 8.213/91, sobre o valor do benefício, em caso de o segurado necessitar de assistência permanente de outra pessoa, independentemente da espécie de aposentadoria – **STF derruba a tese no julgamento do Tema 1.095 (acréscimo de 25% apenas na aposentadoria por incapacidade permanente)**



A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, no julgamento do processo nº 2004.61.84.242410—1, firmou entendimento no sentido de que **“a incapacidade a que se refere a lei não exige que o demandante esteja inapto para a prática de toda e qualquer atividade laboral, mas apenas para aquelas que possam ser exercidas por ele, ou seja, devem ser sopesados os padrões educacional, econômico e social em que o deficiente se encontra inserido”**.

- Precedentes do STJ: analisar as condições pessoais do segurado (invalidez social). O sistema deve fazer a análise das reais possibilidades dentro do mercado de trabalho. Por exemplo, não se pode dizer que um pedreiro que exerceu tal atividade durante toda a vida de 55 anos, analfabeto, está incapaz de exercer trabalho braçal, mas pode exercer atividade intelectual.

Alteração no critério de cálculo pela EC 103/19

- **Utilização da regra do artigo 26 da EC 103/19 – média de 100%/ coeficiente de 60% + 2% para cada ano que supere 15 para a mulher e 20 para o homem**
- **Coeficiente de 100% em casos de acidentes do trabalho**

Temos duas possibilidades na aposentadoria por incapacidade permanente, ou vai ser 100% da média do salário de benefício (100% do salário de contribuição) em casos de acidente do trabalho, ou será 60% + 2% por cada ano que supere 15 anos para a mulher ou 20 anos para o homem.

Ao lado da aposentadoria por incapacidade permanente, temos o auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, que é calculado em 91% do salário de benefício, se for acidentário, e em 91% do salário de benefício se ele for previdenciário ou comum. Temos um limite que é a média das últimas 12 contribuições, sendo que esse limite está sendo questionado pós-Reforma em razão da leitura do art. 29 em diante. Temos casos em que a aposentadoria pode ser menor que o auxílio-doença.

Tema 1300 STF

- É constitucional o cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente



AUXÍLIO DOENÇA (AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA):

Fundamento legal: ARTIGOS 59 a 63 da Lei 8213/91; artigos 71 a 81 do Decreto 3.048/99.

Devido a todos os tipos de segurados. Cuidado com a restrição específica no caso de acidente do trabalho, porque o auxílio por incapacidade temporária tem duas espécies possíveis, podendo ser de natureza previdenciária comum (B31) ou pode ser de natureza acidentária quando decorre de acidente de trabalho (B91).

Exige carência de 12 contribuições mensais no caso de benefício comum e sem carência para acidentes do trabalho ou de qualquer natureza, doenças profissionais ou do trabalho e doenças catalogadas pelo Ministério da Saúde.

Incapacidade total e TEMPORÁRIA.

Associada à possibilidade de tratamento. É por isso que via de regra primeiro recebemos o auxílio por incapacidade temporária para depois sermos aposentados por incapacidade permanente. Primeiro, o segurado vai para o sistema em uma incapacidade temporária no período de tratamento para a recuperação da condição. Porém, se isso não for possível, se após todo o tratamento médico, ele ainda assim ficar incapacitado e isso for considerado insuscetível de reabilitação profissional, ele será aposentado por incapacidade permanente.

A concessão do benefício gera direito subjetivo à percepção dos seguintes serviços: processo de reabilitação profissional e tratamento médico às expensas da Previdência Social.

A reabilitação profissional é uma prerrogativa do sistema de Previdência Social. Se a pessoa sair em um auxílio por incapacidade temporária, ficou afastado, a Previdência não a colocou na reabilitação profissional, voltou a trabalhar na empresa e o médico do trabalho da empresa diz que não dá para a pessoa fazer o que fazia antes, precisa de uma readequação de função.



Aí não chamamos de reabilitação porque reabilitação é uma prerrogativa exclusiva do sistema de Previdência Social, em que o segurado recebendo auxílio por incapacidade temporária vai ao sistema para receber treinamentos, qualificação profissional, próteses que o coloquem na condição de retornar ao mercado de trabalho em condição favorável, de acordo com sua restrição de saúde.

- **TEMA 177 – TNU** – não cabe ao judiciário determinar que o INSS promova a reabilitação, mas sim que proceda a avaliação de elegibilidade.

Todo segurado em auxílio por incapacidade temporária tem direito subjetivo à reabilitação profissional, mas o sistema precisa analisar as condições de elegibilidade. Primeiro se precisa saber se ele tem condição de ser reabilitado para outra atividade. Depois, precisa saber se o quadro dele permite a reabilitação. Talvez não permita e ele tenha que ser aposentado por incapacidade permanente ou talvez não necessite da reabilitação porque o que ele teve está completamente resolvido, voltando a trabalhar normalmente.

A reabilitação é um serviço previdenciário e, sendo um serviço, não tem pagamento, não tem prestação. O sistema determina que o segurado nessa situação que vai para a reabilitação profissional que o pagamento do auxílio por incapacidade temporária seja mantido durante todo o processo de reabilitação.

DOENÇA X INCAPACIDADE

Não tem prazo máximo para pagamento. Ao contrário do que se diz, não existe um prazo em que se fique com o auxílio por incapacidade temporária e que o INSS vai transformar isso em aposentadoria. Enquanto o sistema entender que a condição de incapacidade é temporária, que o segurado está em tratamento médico, não vai ser concedido o benefício definitivo, lembrando que pós Reforma nem sempre pode ser um bom negócio para o segurado transformar um auxílio por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente.

Segurado deve ser submetido aos tratamentos indicados pela Previdência, sendo certo que não é obrigado a submeter-se a procedimento cirúrgico ou transfusão de sangue.



Preservação de liberdade religiosa: não se é obrigado a fazer cirurgia e nem transfusão de sangue. Isso significa dizer que o meu benefício não pode ser cessado pela Previdência Social sob o argumento de que o problema que eu tenho é corrigível por cirurgia, sendo que eu não sou obrigado a fazer cirurgia indicada pelo sistema. Nessa condição, o INSS tem que manter o pagamento do benefício e não cessar porque o segurado se recusa a se submeter a tratamento cirúrgico.

É devido para o segurado que ficar incapacitado por mais de 15 dias consecutivos.

O pagamento de novo benefício decorrente da mesma doença em até 60 dias da cessação do anterior desobriga a empresa do pagamento do período de espera (15 dias).

- Segurado ficou afastado do trabalho de 02/2022 a 04/2022. Em 13/04/2022 ele volta a trabalhar. Um mês depois, em 13/05/2022 ele precisa se afastar de novo pelo mesmo problema porque achou que estava recuperado, mas na verdade trabalhou um tempo, o problema voltou e precisa ser afastado novamente. Ele vai automaticamente porque entre a alta do primeiro benefício e o novo afastamento não deu 60 dias. Assim, a lei desobriga o empregador a pagar esses 15 dias e o trabalhador vai direto ao sistema do INSS.

Alterações da Lei 13.846/2019 → Mini Reforma (MP 871/19)

Art. 59.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

§ 2º Não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado.

§ 3º O segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá o benefício suspenso.

§ 4º A suspensão prevista no § 3º deste artigo será de até 60 (sessenta) dias, contados da data do recolhimento à prisão, cessado o benefício após o referido prazo.

§ 5º Na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no § 4º deste artigo, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura.



§ 6º Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido.

§ 7º O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º deste artigo aplica-se somente aos benefícios dos segurados que forem recolhidos à prisão a partir da data de publicação desta Lei.

- *Tempus regit actum*. Fato gerador = recolhimento à prisão.

§ 8º O segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá direito ao auxílio-doença

Não há nenhuma justificativa na legislação para excluirmos o segurado em regime fechado do direito ao recebimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária, gerando direito ao auxílio-reclusão. Se ele é um segurado contribuinte da Previdência Social, não há motivo para esse discrimen. Existe aquela situação em que o segurado é recluso em regime fechado já recebendo auxílio por incapacidade temporária. O que vai acontecer? Suspensão do benefício para se manter a isonomia.

Cessaç o do benefício com **a morte (gera hipoteticamente pens o por morte), o restabelecimento do segurado;** a convers o da aposentadoria por invalidez ou a habilita  o para outra atividade que lhe garanta a subsist ncia, ap s processo de reabilita  o.

Pode ser concedido de of cio pela Previd ncia quando tiver ci ncia da incapacidade, mesmo quando o segurado n o tenha requerido o benef cio. Igual ocorre com a aposentadoria por incapacidade permanente.

O exame m dico, **a cargo do INSS pelo perito m dico federal**, fixar  a data do in cio da doen a (DID) e a data do in cio da incapacidade (DII), que   extremamente importante para que o sistema avalie as quest es relacionadas   preexist ncia e existe um elemento muito importante quando falamos da DII que   saber se esta data est  antes da EC 103/19 (crit rios de c culo) ou depois (Enunciado 213 do FONAJEF).



COPES – Cobertura Previdenciária estimada – alta programada (data estimada de recuperação). **O segurado pode pedir, neste caso, a prorrogação do benefício (PP), nos 15 dias anteriores à alta programada.** Se não houver recuperação, pode ser feito pedido de prorrogação 15 dias antes da alta programada e força o sistema a realizar nova perícia e o benefício será mantido pelo menos até a reavaliação da perícia médica.

Pode ser por doença comum (B31) ou por acidente do trabalho (B91). É o acidentário que vai gerar a estabilidade de pelo menos 12 meses no emprego após a alta prevista no art. 118 da Lei n. 8.213/91 e Súmula 378 do TST, lembrando que as convenções coletivas podem flexibilizar e aumenta essa estabilidade. O acidentário também obriga o recolhimento de FGTS no período de afastamento.

ATENÇÃO – ALTERAÇÃO DA LEI 13.457/2017:

Art. 60

§ 8º Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício → alta programada.

Essa é uma regra que deve ser aplicada também nos processos judiciais, o que significa que você pediu um auxílio por incapacidade temporária judicialmente e a sentença deve fixar o prazo estimado de duração do benefício, o prazo em que deve ser feita a reavaliação do segurado.

§ 9º Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8º deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei.

§ 10. O segurado em gozo de auxílio-doença, concedido judicial ou administrativamente, poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, observado o disposto no art. 101 desta Lei.

Existe também reavaliação no auxílio por incapacidade temporária e o segurado não pode se recusar porque se ele for chamado para fazer uma perícia de reavaliação (pente-fino) e não comparecer, o benefício será cessado.



A TNU tem entendimento de que o pedido de prorrogação é condição para a ação porque o segurado que deixa o benefício cessar não tem interesse de agir para demandar judicialmente.

Bloco 4

§ 11. O segurado que não concordar com o resultado da avaliação da qual dispõe o § 10 deste artigo poderá apresentar, no prazo máximo de trinta dias, recurso da decisão da administração perante o Conselho de Recursos do Seguro Social, cuja análise médica pericial, se necessária, será feita pelo assistente técnico médico da junta de recursos do seguro social, perito diverso daquele que indeferiu o benefício.”

Esse é um recurso previdenciário, um recurso administrativo e deve ser interposto no prazo de 30 dias e vai para o Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS), depois as Juntas de Recursos, Câmaras de Julgamento e eventualmente o Conselho Pleno, que são os componentes do CRPS. Veremos adiante a alteração trazida pela MP 1113/22 e Lei n. 14.331/22 que alteram o art. 126 da Lei n. 8.213, alterando a competência saindo da CRPS e indo para outra Secretaria.

“Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

§ 1º O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.

§ 2º A alteração das atribuições e responsabilidades do segurado compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental não configura desvio de cargo ou função do segurado reabilitado ou que estiver em processo de reabilitação profissional a cargo do INSS. (Lei 13846/19)”

O que acontece em muitas situações é que o segurado com limitação que passa em razão do processo de reabilitação profissional a exercer outra atividade compatível com a sua capacidade física, isso na forma da lei previdenciária não significa desvio de cargo ou de função, significa apenas que a atividade profissional foi



adequada à sua condição de saúde. Durante a reabilitação, que não é prestação pecuniária, fica mantido o pagamento do auxílio-doença.

§ 11-A. O exame médico-pericial para o auxílio-doença previsto no *caput* e no § 10, a cargo da Previdência Social, poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental, conforme as situações e os requisitos estabelecidos em regulamento. [\(Redação dada pela Lei nº 15.265, de 2025\)](#)

§ 14. Ato do Ministro de Estado do Trabalho e Previdência poderá estabelecer as condições de dispensa da emissão de parecer conclusivo da perícia médica federal quanto à incapacidade laboral, hipótese na qual a concessão do benefício de que trata este artigo será feita por meio de análise documental, incluídos atestados ou laudos médicos, realizada pelo INSS. [\(Incluído pela Lei nº 14.441, de 2022\)](#)

§ 15. Os segurados com síndrome da imunodeficiência adquirida, doença de Alzheimer, doença de Parkinson e esclerose lateral amiotrófica são dispensados da avaliação referida no § 10 deste artigo. [\(Incluído pela Lei nº 15.157, de 2025\)](#)

§ 16. A perícia médica de segurado com síndrome da imunodeficiência adquirida deverá ter a participação de pelo menos 1 (um) médico especialista em infectologia. [\(Incluído pela Lei nº 15.157, de 2025\)](#)

Cessaç o do benef cio com **a morte, o restabelecimento do segurado**; a convers o da aposentadoria por invalidez ou a habilita  o para outra atividade que lhe garanta a subsist ncia, ap s processo de reabilita  o.

Pode ser concedido de of cio pela Previd ncia quando tiver ci ncia da incapacidade, mesmo quando o segurado n o tenha requerido o benef cio.

O exame m dico, a cargo do INSS, fixar  a data do in cio da doen a (DID) e a data do in cio da incapacidade (DII).



COPES – Cobertura Previdenciária estimada – alta programada. O segurado pode pedir, neste caso, a prorrogação do benefício (PP), nos 15 dias anteriores à alta programada.

Pode ser por doença comum (B31) ou por acidente do trabalho (B91).

“Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

§ 1º O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.

§ 2º A alteração das atribuições e responsabilidades do segurado compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental não configura desvio de cargo ou função do segurado reabilitado ou que estiver em processo de reabilitação profissional a cargo do INSS. (Lei 13846/19)”

ALTERAÇÃO DA LEI 13.847/19 – art. 43

O portador de HIV está dispensado do exame de reavaliação das condições que ensejaram a aposentadoria por invalidez → TNU diz que essa regra não retroage para atingir aposentadorias eventualmente cessadas de pessoas com HIV anteriormente à vigência desta Lei n. 13.847/19.

Isentos de reavaliação (art. 101 e 43):

- 55 anos de idade/15 anos de benefício
- 60 anos de idade
- Portador de HIV

JURISPRUDÊNCIA:



Tema 692 – STJ – Devolução dos valores recebidos em razão de reforma de decisão de antecipação de tutela, desconto até 30% do benefício (Tema 799 STF – sem repercussão/transitado) (obs: para servidor público – desconto 10% - Lei 8112/91)

Art. 115 da 8213/91 – devolução de 30% do benefício

Alguém entrou com ação para buscar auxílio por incapacidade temporária, se submeteu a prova pericial e veio a decisão entendendo que havia a probabilidade do direito, antecipando a tutela, determinando que o INSS concedesse o benefício. O INSS recorreu e teve sucesso em seu recurso, consequentemente a decisão foi cassada e o segurado, em razão de tutela deferida judicialmente, recebeu o benefício, porém essa decisão de concessão foi cassada e o entendimento do STJ, ao dividir a boa-fé em objetiva e subjetiva, é de que nessas situações, o segurado tem plena consciência da precariedade da decisão e, se esta for cassada, ele deve devolver os valores.

Tema 979 – STJ – Tese firmada: Com relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, **são repetíveis**, sendo legítimo o desconto no percentual de até 30% (trinta por cento – art. 115 da Lei n. 8.213/91) de valor do benefício pago ao segurado/beneficiário, **ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.**

Se o segurado, mesmo recebendo um valor indevido por erro da administração e que a regra é para que se devolva, comprova a sua boa-fé objetiva, especialmente provando que não tinha como saber que estava recebendo de forma equivocada, neste caso ele vai ficar isento da devolução para essas situações em que a verba será não repetível. O STF, especialmente na modulação dos efeitos das decisões, sempre vem trabalhando nessa questão da devolução dos valores e já fez isso em vários julgamentos preservando a irrepetibilidade de valores recebidos pelos segurados em razão dessas teses que chegam lá, como desaposentação, aposentadoria especial, acréscimo de 25% nas demais espécies de aposentadoria, etc.



Súmula 53 da TNU – Não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez quando a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de Previdência Social”.

Súmula 72 da TNU – “É possível o recebimento de benefício por incapacidade durante o período em que houve exercício de atividade remunerada quando comprovado que o segurado estava incapaz para as atividades habituais na época em que trabalhou”. POSIÇÃO RATIFICADA PELO STJ – TEMA 1.013

Muitas vezes durante o curso do processo judicial, o segurado acaba voltando ao mercado de trabalho, exercendo uma atividade laborativa justamente pelo fato de que ele precisa sobreviver. Imagina que o segurado entrou com a ação em 10/03/2020 para pedir auxílio-doença. A sentença procedente reconhecendo o benefício só saiu em 10/03/2022. Nesses 2 anos, o segurado não recebeu do INSS e se não recebesse salário, não teria condições de sobrevivência. Deve ser pago os atrasados porque esse segurado evidentemente incapacitado trabalhou este período por questão de sobrevivência, ele não tinha outra opção.

Súmula 47 TNU – “Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez”

Esse é o entendimento do STJ. Se você lançar incapacidade parcial no site do STJ, você vai localizar muitos acórdãos. Na TNU especialmente, essa situação da invalidez social já está expressamente determinada nesta súmula 47, que vimos. Com relação à avaliação da capacidade laborativa, vamos além da análise puramente médica para analisar a escolaridade, a aptidão e aspectos pessoais do segurado.

Súmula 25 da AGU – será concedido auxílio-doença ao segurado quando a incapacidade for considerada temporária e total ou parcial (aquela que permite reabilitação para outras atividades laborais)

Precedentes STJ – Resp 699920/SP/ Resp 1.474.476/SP



Tema: 259 TNU: É possível a cumulação de benefício de auxílio-doença (auxílio por incapacidade temporária) com o exercício de mandato eletivo de vereador, desde que observado o disposto no §7º do artigo 60 da Lei nº 8.213/91)

Necessidade do pedido de prorrogação para interesse de agir:

Tema	277	Situação do tema	Julgado	Ramo do direito	DIREITO PREVIDENCIÁRIO
Questão submetida a julgamento	Saber, à vista do decidido no Tema 164/TNU, quais as consequências da ausência de pedido administrativo de prorrogação do auxílio-doença cessado por alta programada na postulação judicial de restabelecimento do benefício.				
Tese firmada	O direito à continuidade do benefício por incapacidade temporária com estimativa de DCB (alta programada) pressupõe, por parte do segurado, pedido de prorrogação (§ 9º, art. 60 da Lei n. 8.213/91), recurso administrativo ou pedido de reconsideração, quando previstos normativamente, sem o quê não se configura interesse de agir em juízo.				
Processo	Decisão de afetação	Relator (a)	Julgado em	Acórdão publicado em	Trânsito em julgado
PEDILEF 0500255-75.2019.4.05.8303/PE	16/10/2020	Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves	17/03/2022	17/03/2022	25/04/2022

Essa questão do interesse de agir no benefício por incapacidade é uma questão bastante sensível para o segurado e a TNU tem o entendimento de que se o segurado pediu o benefício por incapacidade hoje, o INSS concede e diz que a cessação está prevista para 10/outubro/2022. O segurado tem o ônus de pedir a prorrogação 15 dias antes. Se não pedir e deixar cessar, inexistente interesse de agir, conforme entendimento da TNU.



Tema	343	Situação do tema	Julgado	Ramo do direito	DIREITO PREVIDENCIÁRIO
Questão submetida a julgamento	Saber qual o termo inicial para fixação da data de início do benefício quando o perito judicial reconhece o estado incapacitante alegado pela parte desde o requerimento administrativo/cessação do benefício na via administrativa/propositura da ação, mas não sabe precisar, efetivamente, a data de início da incapacidade.				
Tese firmada	A fixação da data de início da incapacidade (DII) na data da perícia constitui medida excepcional, que demanda fundamentação capaz de afastar a presunção lógica de que a incapacidade teve início em momento anterior ao exame pericial.				
Processo	Decisão de afetação	Relator (a)	Julgado em	Acórdão publicado em	Trânsito em julgado
PEDILEF 0523447-97.2020.4.05.8013/AL	19/10/2023	Juíza Federal Lillian Oliveira da Costa Tourinho - Para acórdão: Juiz Federal Fábio de Souza Silva	09/04/2025	14/04/2025 11/03/2026 (ED)	17/04/2026

Documento 1	Assuntos		Selecionar	
Tema Repetitivo 1246	Situação	Trânsito em Julgado	Órgão julgador	PRIMEIRA SEÇÃO
			Ramo do direito	DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO
Questão submetida a julgamento	(In)admissibilidade de recurso especial interposto para rediscutir as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento, em caso concreto em que se controverte quanto a benefício previdenciário por incapacidade (aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente), do requisito legal da incapacidade do segurado para o exercício de atividade laborativa, seja pela vertente de sua existência, de sua extensão (total ou parcial) e/ou de sua duração (temporária ou permanente).			
Tese Firmada	É inadmissível recurso especial interposto para rediscutir as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento, em caso concreto em que se controverte quanto a benefício por incapacidade (aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente), do requisito legal da incapacidade do segurado para o exercício de atividade laborativa, seja pela vertente de sua existência, de sua extensão (total ou parcial) e/ou de sua duração (temporária ou permanente).			



Documento 1	Assuntos	Selecionar
Tema Repetitivo 1157	Situação Mérito Julgado	Órgão julgador PRIMEIRA SEÇÃO Ramo do direito DIREITO PREVIDENCIÁRIO
Questão submetida a julgamento	Definir a possibilidade - ou não - de cancelamento na via administrativa, após regular realização de perícia médica, dos benefícios previdenciários por incapacidade, concedidos judicialmente e após o trânsito em julgado, independentemente de propositura de ação revisional.	
Tese Firmada	*Aguardando a publicação do acórdão do julgamento de mérito.	



O pente fino foi melhor dimensionado por essa novidade legislativa, essa lei definiu os ônus de pagamento da perícia médica e trouxe alteração no rito processual dos benefícios por incapacidade.

Art. 2º O art. 1º da Lei nº 13.876, de 20 de setembro de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação:



“Art. 1º O ônus pelos encargos relativos ao pagamento dos honorários periciais referentes às perícias judiciais realizadas em ações em que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) figure como parte e se discuta a concessão de benefícios assistenciais à pessoa com deficiência ou benefícios previdenciários decorrentes de incapacidade laboral ficará a **cargo do vencido**, nos termos da legislação processual civil, em especial do § 3º do art. 98 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

§ 3º (Revogado).

§ 4º O pagamento dos honorários periciais **limita-se a 1 (uma) perícia médica por processo judicial**, e, excepcionalmente, caso determinado por instâncias superiores do Poder Judiciário, outra perícia poderá ser realizada.

Se o segurado tem um problema ortopédico e um problema cardíaco, deve realizar uma perícia só pela limitação orçamentária, salvo determinação em instâncias superiores.

§ 5º A partir de 2022, nas ações a que se refere o **caput** deste artigo, **fica invertido o ônus da antecipação da perícia**, cabendo ao réu, qualquer que seja o rito ou procedimento adotado, antecipar o pagamento do valor estipulado para a realização da perícia, exceto na hipótese prevista no § 6º deste artigo.

§ 6º Os autores de ações judiciais relacionadas a benefícios assistenciais à pessoa com deficiência ou a benefícios previdenciários decorrentes de incapacidade laboral previstas no **caput** deste artigo que **comprovadamente disponham de condição suficiente para arcar com os custos de antecipação das despesas referentes às perícias médicas judiciais deverão antecipar os custos dos encargos relativos ao pagamento dos honorários periciais**.

Basicamente, quem antecipa os ônus periciais é o INSS. Se, na hipótese de comprovadamente em que o autor da ação que discuta benefício assistencial ou benefício por incapacidade tiver condição, o ônus pericial é dele. Se o segurado for beneficiário da gratuidade da justiça, temos uma presunção de que ele não tem condições de arcar com as custas. O INSS tem o ônus de comprovar que aquele litigante especificamente tem as condições.

Art. 3º A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 129-A e 135-A:

“Art. 129-A. Os litígios e as medidas cautelares relativos aos benefícios por incapacidade de que trata esta Lei, inclusive os relativos a **acidentes do trabalho**, observarão o seguinte:



- Essa regra vai valer na Justiça Federal e na Justiça Estadual (acidente do trabalho – 109, I da CF).

I – quando o fundamento da ação for a discussão de ato praticado pela perícia médica federal, a petição inicial deverá conter, em complemento aos requisitos previstos no art. 319 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil):

- a) descrição clara da doença e das limitações que ela impõe;
- b) indicação da atividade para a qual o autor alega estar incapacitado;
- c) possíveis inconsistências da avaliação médico-pericial discutida; e
- d) declaração quanto à existência de ação judicial anterior com o objeto de que trata este artigo, esclarecendo os motivos pelos quais se entende não haver litispendência ou coisa julgada, quando for o caso;

Além de termos uma perfeita delimitação do pedido, temos que justificar onde está o erro da perícia médica federal que está se demandando judicialmente para dizer que não concorda, dizer qual a atividade do segurado, contendo declaração de inexistência de demandas anteriores relacionadas ao mesmo tema para análise de litispendência e coisa julgada (algo que normalmente é matéria de defesa, do INSS).

II – para atendimento do disposto no art. 320 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), a petição inicial, qualquer que seja o rito ou procedimento adotado, deverá ser instruída pelo autor com os seguintes documentos:

- a) comprovante de indeferimento do benefício ou de sua não prorrogação, quando for o caso, pela administração pública;
- b) comprovante da ocorrência do acidente de qualquer natureza ou do acidente do trabalho, sempre que houver um acidente apontado como causa da incapacidade;

Sabemos que a prova do acidente, especialmente do acidente do trabalho, não é uma prova tão fácil e muitas vezes quando o segurado vai demandar questões relacionadas ao acidente de trabalho, ele vai fazer a prova do nexo dentro da própria ação por vistoria ou prova testemunhal justamente pelo fato de que quando a empresa reconhece o acidente, gera para si uma série de consequências tributárias e trabalhistas.



c) documentação médica de que dispuser relativa à doença alegada como a causa da incapacidade discutida na via administrativa.

§ 1º Determinada pelo juízo a realização de exame médico-pericial por perito do juízo, este deverá, no caso de divergência com as conclusões do laudo administrativo, indicar em seu laudo de forma fundamentada as razões técnicas e científicas que amparam o dissenso, especialmente no que se refere à comprovação da incapacidade, sua data de início e a sua correlação com a atividade laboral do periciando.

§ 2º Quando a conclusão do exame médico pericial realizado por perito designado pelo juízo mantiver o resultado da decisão proferida pela perícia realizada na via administrativa, poderá o juízo, após a oitiva da parte autora, julgar improcedente o pedido.

Isso seria um julgamento liminar de improcedência. Se o perito judicial discordar de decisão, deverá fundamentar. Se o perito judicial concordar com a perícia administrativa, o juiz vai ouvir a parte autora e julgar improcedente em julgamento liminar de improcedência, antes mesmo de citar o réu.

§ 3º Se a controvérsia versar sobre outros pontos além do que exige exame médico-pericial, observado o disposto no § 1º deste artigo, o juízo dará seguimento ao processo, com a citação do réu.”

Bloco 5

AUXÍLIO ACIDENTE

Não se confunde com o auxílio-doença acidentário, sendo outro benefício previsto na legislação, com natureza indenizatória que tem essa finalidade de indenizar o segurado na forma de prestação mensal quando ele fica com uma sequela de um acidente de qualquer natureza ou de um acidente de trabalho e lembrando que todas as vezes que falamos de acidente de trabalho, lembramos do acidente típico, a doença profissional, a doença do trabalho, as concausas e as equiparações.



Trata de incapacidade parcial e permanente (segundo letra de lei: redução da capacidade laborativa)

Fundamento legal: Artigo 86 da Lei 8213/91 e 104 do Decreto 3048/99.

Não há carência – art. 26, I, da Lei 8213/91. Exige qualidade de segurado ou pelo menos o período de graça.

Surge em razão da consolidação ou redução da capacidade decorrente de acidente de qualquer natureza ou doença profissional ou doença do trabalho.

Para o acidente de qualquer natureza (atropelamento saindo da pizzeria no domingo), a competência para decidir é da Justiça Federal, ainda que seja empregado.

CONCEITO: será devido ao segurado (empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e segurado especial) após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, que resultem em redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia ou impossibilidade de exercício da mesma atividade da época do acidente, mas com possibilidade de desempenho de outra, após processo de reabilitação profissional.

- Natureza indenizatória
- Não mantém qualidade de segurado

Incapacidade parcial e permanente. Sequela com lesão consolidada, irreversível decorrente do acidente, do evento, doença, concausa ou equiparação.

Benefício de caráter indenizatório, ou seja, não substitui salário, ou seja, pode ter valor inferior a um salário mínimo.

O segurado PODE trabalhar e receber o benefício ao mesmo tempo. É indenizatório e não substituir a remuneração do segurado.



Sofri um acidente de trabalho em 15/02/2022 porque estava operando uma serra circular e perdi o dedo na máquina. Os primeiros 15 dias quem paga o salário é o INSS, do 16º dia em diante, vou receber auxílio por incapacidade temporária de natureza acidentária (gera estabilidade depois da alta e direito de recolhimento de FGTS no período de afastamento) pelo tempo de tratamento. Depois que cessa o auxílio por incapacidade temporária de natureza acidentária é que o INSS vai avaliar se eu preencho os requisitos legais para o auxílio-acidente, que raramente é concedido na via administrativa.

Para o INSS, a perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente quando, além do reconhecimento do nexo de causal entre o trabalho e a doença, resultar comprovadamente redução ou perda da capacidade para o trabalho.

A fim de analisar a perda auditiva induzida por ruído ocupacional, faz-se um cálculo dessa perda com base em algumas tabelas e essas tabelas definem a incapacidade de acordo com graus de comprometimento e a lei diz claramente que o grau de comprometimento não pode impactar a definição se há sequela ou não, o que deve impactar é de fato se aquela redução, aquela restrição acarreta em uma perda ou redução da capacidade de trabalho.

Benefício tem **início** no dia seguinte ao da cessação do auxílio doença e **cessa** com a concessão de qualquer aposentadoria. (Tema 862 do STJ).

Sujeitos ativos são os segurados empregados, empregados domésticos (LC 150/2015), trabalhadores avulsos e segurados especiais.

O artigo 104, III, do Decreto nº 3048/99, regulamentando a norma do artigo 86 da Lei 8.213/91, estabelece, com absoluta clareza, que será devido o auxílio-acidente de 50% quando se verificar **“impossibilidade de desempenho da atividade que exerciam à época do acidente, porém permita o desempenho de outra, após processo de reabilitação profissional, nos casos indicados pela perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social.**

JURISPRUDÊNCIA



- Resp 1.112.886-SP = Auxílio acidente devido mesmo que a moléstia não seja irreversível – LER/DORT; - tema 156 do STJ:

- Resp 1.109.591-SC = auxílio acidente devido mesmo que a lesão seja mínima (50% salário de benefício); - tema 416 do STJ

Se precisamos que a sequela ou lesão atinja determinado grau ou basta que ela tenha alguma repercussão na capacidade laborativa do segurado e esse é o entendimento do STJ. Basta que tenhamos uma repercussão. Se temos, por exemplo, um segurado que sofre uma amputação de pequena parte de um dos seus dedos, não é porque um segurado que sofreu tal amputação vai fazer jus ao mesmo benefício que ele não terá direito porque se aquela lesão/sequela de alguma maneira compromete o exercício da atividade laborativa dele, então tem repercussão e, por isso, tem direito ao auxílio-acidente.

- Resp 1095523/SP – tema 22 – Grau de disacusia abaixo do mínimo previsto na Tabela de Fowler (interessa a repercussão)

- Súmula 507 STJ – acumulação de auxílio-acidente e aposentadoria – questão está no STF (tema 599 – manteve o entendimento de que não acumula)

Até a Lei n. 9.528/97, o benefício do auxílio-acidente era vitalício. Depois da Lei n. 9.528/97, ele passa a ser devido até a véspera de qualquer aposentadoria e é incorporado no cálculo (art. 31 da Lei n. 8.213/91). O auxílio-acidente devido até a véspera da aposentadoria, incorporado ao salário de contribuição para efeito de cálculo do salário de benefício da aposentadoria que o segurado vai receber. Somamos no salário de contribuição o valor do auxílio-acidente. Ele impacta a depender da data de início do benefício.

O STJ sempre teve o entendimento de que o auxílio-acidente concedido antes da Lei n. 9.528/97, por força do direito adquirido, era vitalício. Na Súmula 507, o STJ mudou seu entendimento para dizer que, para que se tenha



direito adquirido, precisamos que o auxílio-acidente e a aposentadoria sejam anteriores à Lei n. 9.528/97. Se ambos forem anteriores, o segurado tem direito adquirido.

- Tema 862 STJ – termo inicial do AA (julgado – alta do auxílio doença)

Tema	315	Situação do tema	Em Julgamento	Ramo do direito	DIREITO PREVIDENCIÁRIO
Questão submetida a julgamento	Saber se, nos casos de ausência de pedido de prorrogação, o início dos efeitos financeiros do auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, deve ser fixado na data da citação válida ou no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.				
Tese firmada	A data do início do benefício de auxílio-acidente é o dia seguinte à data da cessação do benefício de auxílio por incapacidade temporária, que lhe deu origem, independentemente de pedido de prorrogação deste ou de pedido específico de concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observada a prescrição quinquenal dos valores atrasados.				
Processo	Decisão de afetação	Relator (a)	Julgado em	Acórdão publicado em	Trânsito em julgado
PEDILEF 5063339-35.2020.4.04.7100/RS	10/11/2022	Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves - para acórdão: Juíza Federal Lillian Oliveira da Costa Tourinho	18/10/2023	26/10/2023	

Tema	322	Situação do tema	Julgado	Ramo do direito	DIREITO PREVIDENCIÁRIO
Questão submetida a julgamento	Saber se devem ser computados os valores percebidos a título de auxílio-acidente no período básico de cálculo (PBC) da aposentadoria por idade rural do segurado especial, para fins de incremento da renda mensal inicial (RMI), independentemente do recolhimento de contribuições facultativas.				
Tese firmada	Devem ser computados os valores percebidos a título de auxílio-acidente no período básico de cálculo (PBC) da aposentadoria por idade rural do segurado especial, para fins de incremento da renda mensal inicial (RMI), independentemente do recolhimento de contribuições facultativas, a teor do inciso II do artigo 34 da Lei n. 8.213/91, excetuadas as hipóteses de cumulação de benefícios contempladas na Súmula 507 do STJ.				
Processo	Decisão de afetação	Relator (a)	Julgado em	Acórdão publicado em	Trânsito em julgado
PEDILEF 5014634-54.2021.4.04.7202/SC	15/03/2023	Juíza Federal Luciana Ortiz Tavares Costa Zanoni	22/11/2023	24/11/2023	

Lei 14441/22



“Art. 60

§14 – Ato do Ministro de Estado do Trabalho e Previdência poderá estabelecer as condições de dispensa da emissão de parecer conclusivo da perícia médica federal quanto à incapacidade laboral, hipótese na qual a concessão do benefício de que trata este artigo será feita por meio de análise documental, incluídos atestados ou laudos médicos, realizada pelo INSS.”

“Art. 101. O segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente ou aposentadoria por incapacidade permanente e o pensionista inválido, cujos benefícios tenham sido concedidos judicial ou administrativamente, estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a:

- I - exame médico a cargo da Previdência Social para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção;
- II - processo de reabilitação profissional prescrito e custeado pela Previdência Social; e
- III - tratamento oferecido gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.